Psychiatrie
Trouble panique
avec patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Marchal Lucile **Date de rédaction : 05/12/23**

Situation de départ N° 116 – Anxiété

Domaine de compétence n°1 : Annonce

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

- Connaître la définition de la crise d'angoisse et de l'attaque de panique
- Connaître la prévalence et les âges concernés
- Connaître les facteurs de risque et mécanismes psychophysiologiques
- Connaître les modalités de diagnostic d'une attaque de panique
- Connaître les diagnostics différentiels psychiatriques et non psychiatriques
- Connaître la prise en charge de l'attaque de panique en aigu
- Connaître la prise en charge à distance de l'attaque de panique

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Aucun matériel nécessaire

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Vous avez 21 ans et vous êtes étudiant(e) en lettres. Depuis quelques mois vous avez des sensations très invalidantes ponctuelles qui vous handicapent de plus en plus. Vous ne pouvez plus mener vos activités sans craindre une nouvelle "crise". Vous ignorez de quoi il s'agit. Une amie vous a conseillé de voir un psychiatre. Un interne en psychiatrie va vous interroger. Pas de contact physique.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : TROPA Prénom : Julie Age : 21 Etudiante Célibataire sans enfants Vit dans un appartement à Nice
Antécédents	Aucun, aucune allergie
Médicaments actuels/ Toxiques	*Tabac 10 cigarettes par jour depuis 5 ans* *Aucun traitement*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : marche Douleur : aucune Angoisse : modérée pendant l'entretien Colère : faible Autre : Paraît désemparée
Déroulement du scénario	Vous êtes assise. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *"J'ai des sensations très étranges depuis quelques mois. C'est très invalidant."* Puis répondez aux questions de l'étudiant et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Il ne doit pas vous examiner. Pas de question 1 minute avant la fin, sauf si l'étudiant n'a pas commencé l'éducation thérapeutique. Auquel cas demander : " Docteur, comment vous allez me soigner ?"
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	"J'ai peur de devenir folle, c'est le cas ?" après avoir fini d'expliquer ses symptômes "Comment éviter les crises ?" pendant l'éducation thérapeutique "Comment calmer les crises ?" pendant l'éducation thérapeutique

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Qu'entendez-vous par "des sensations très étranges" ?	J'ai souvent l'impression de ne plus arriver à respirer, mon cœur bat très vite, j'ai le tournis et je me sens "mal".
C'est à dire "mal" ?	J'ai l'impression que je vais mourir. Des fois je n'arrive plus vraiment à bouger. J'ai l'impression que je vais m'évanouir ou même mourir. Parfois c'est comme si mon corps ne m'appartenait pas. Tout me paraît étranger et je me sens comme spectatrice de la scène.
Vous avez ces symptômes tout le temps ou seulement de temps en temps ? / A quelle fréquence ont lieu ces épisodes ?	Seulement de temps en temps, au début c'était rare mais maintenant ça m'arrive tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour.
Combien de temps dure un épisode ?	Environ 30 minutes.
Depuis combien de temps cela vous arrive ?	Depuis environ 4 mois.
Avez-vous l'impression que ces épisodes sont déclenchés par quelque chose de spécifique ?	Non. En tous cas au début c'était vraiment aléatoire. Mais maintenant dès que j'y pense je peux être sûre que je vais avoir un épisode. C'est comme si le stress d'avoir une crise m'en provoquait vraiment une.
Consommez-vous du tabac, de l'alcool, du cannabis ou autre drogue ?	J'ai consommé du cannabis quand j'étais plus jeune (mais plus maintenant) et je fume 10 cigarettes par jour depuis environ 5 ans. Je ne bois pas d'alcool.
Vous sentez-vous stressée/anxieuse dans votre vie de tous les jours ?	Pas vraiment en général. Ma vie allait bien avant. Par contre depuis que je fais mes crises régulièrement j'ai très peur de sortir. Je ne vois presque plus mes amis.
Vous ne voyez plus nos amis/ vous sortez moins/ vous avez peur d'être dans certains endroits ?	Je préfère rester chez moi. J'ai peur de faire une crise à un endroit où personne ne pourrait me venir en aide. Du coup je ne vais plus en cours. Je pense que je vais redoubler. En plus je ne veux plus conduire depuis que j'ai fait une crise au volant.
Comment s'est passée la crise au volant ?	J'ai eu mes symptômes habituels et j'avais de gros vertiges donc j'étais très stressée à l'idée de m'évanouir et de causer un accident. Je respirais très fort et j'avais des fourmillements dans les mains. J'avais beaucoup de mal à passer les vitesses. Comme si ma main était un peu paralysée et ne pouvait plus bouger correctement.

Est-ce que vous vous sentez triste/manque d'énergie/ en ce moment ?	Non pas vraiment. Je suis un peu triste de ne plus pouvoir voir mes amis comme avant mais c'est tout.
Vous dormez bien ?	Oui, aucun problème pour ça. Je m'endors parfois très tard par choix mais je dors très bien.
Vous faites du sport/ une activité physique régulière ?	Non.
Vous avez des antécédents personnels ou familiaux de pathologies cardiovasculaires/ neurologiques/ endocriniennes/ respiratoires (ex : épilepsie, troubles du rythme, cardiopathie, asthme, hyperthyroïdie) ?	Non, rien de tout ça.
Pendant les crises avez-vous : Nausées, envies pressentes d'uriner, douleurs, diarrhées	Rien de tout ça.
Pendant les crises avez-vous : Tremblements, sueurs, sensation de poids sur la poitrine, étourdissement/vertige, pâleur, palpitations.	Oui ! J'ai ces symptômes. Mais pas forcément à chaque crise. Ça peut varier en fonction des crises.
Pendant les crises avez-vous : L'impression que vous allez mourir/devenir folle, que votre corps ne vous appartient pas, que le monde autour de vous est irréel.	C'est exactement ce qui m'arrive. J'ai du mal à en parler, on dirait que je deviens folle.
Êtes-vous agitée ou au contraire calme pendant les crises ?	Je suis le plus souvent calme, souvent je me mets en retrait le temps que ça passe, surtout si cela m'arrive en public.
Avez-vous déjà pensé à vous faire du mal pendant, ou en dehors d'une crise ?	Non jamais.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en consultations de psychiatrie.

Madame Julie Tropa, 21 ans vous consulte ce jour pour la première fois.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Mener l'interrogatoire de la patiente et donner le diagnostic.

2. Effectuer une éducation thérapeutique de la patiente et juger de l'indication d'un traitement pharmacologique.

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche une consommation de substance psychoactives (au moins cannabis et alcool)	
Cherche des antécédents (*notamment neurologiques et cardiovasculaires*) pour écarter un diagnostic différentiel non psychiatrique	

Cherche à connaître la date de début des troubles	
Cherche la fréquence des crises	
Cherche la durée des crises	
Recherche une agoraphobie associée	
Cherche une pathologie psychiatrique associée (*évalue la thymie et l'anxiété générale de la patiente*)	
Cherche à faire développer ses symptômes par la patiente : *en cherche au moins 4 parmi* - nausées/vomissements, - pollakiurie, - douleurs, - diarrhées, - tremblements, - paresthésies, - pseudo-paralysie, - sueurs, - sensation de pression thoracique, - palpitations, - étourdissement/vertige, - pâleur, - sensation de catastrophe imminente (mourir/folie), - déréalisation/dépersonnalisation	
Pose le diagnostic d'attaques de panique/ crises d'angoisse à répétition	
Pose le diagnostic de trouble panique avec agoraphobie	
Tache 2	
Informe sur l'absence de danger de la pathologie, rassure quant au fait que la patiente n'est pas en train de "devenir folle"	
Donne des stratégies pour calmer la crise (*au moins 2 parmi : se mettre au calme, contrôle de la respiration avec expiration lente, focaliser son attention, limiter l'hyperventilation*)	
Cite le traitement par benzodiazépine per os comme traitement ponctuel de crise éventuelle	
Conseille des règles hygiéno-diététiques à suivre, au moins 2 parmi les suivantes : arrêt des excitants (*café, tabac)*, sommeil régulier, bon équilibre alimentaire, activité physique régulière, techniques de relaxation	
Cite les antidépresseurs/inhibiteurs sélectifs de la sérotonine comme traitement de fond éventuel	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A ECOUTER	
APTITUDE A QUESTIONNER	
APTITUDE A STRUCTURER/MENER L'ENTREVUE	
APTITUDE A PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Recherche une consommation de substance psychoactives (au moins cannabis et alcool)	2

Cherche des antécédents (notamment neurologiques et cardiovasculaires) pour écarter un diagnostic différentiel non psychiatrique	3
Cherche à connaître la date de début des troubles	2
Cherche la fréquence des crises	1
Cherche la durée des crises	1
Recherche une agoraphobie associée	4
Cherche une pathologie psychiatrique associée (évalue la thymie et l'anxiété générale de la patiente)	2
Cherche à faire développer ses symptômes par la patiente, en cherche au moins 6 parmi : nausées/vomissements, pollakiurie, douleurs, diarrhées, tremblements, paresthésies, pseudo-paralysie, sueurs, sensation de pression thoracique, palpitations, étourdissement/vertige, pâleur, sensation de catastrophe imminente (mourir/folie), déréalisation/dépersonnalisation	3
Pose le diagnostic d'attaques de panique/ crises d'angoisse à répétition engendrant un trouble panique avec agoraphobie	5
Tache 2	
Informe sur l'absence de danger de la pathologie et rassure quant au fait que la patiente n'est pas en train de "devenir folle"	4
Donne des stratégies pour calmer la crise (au moins 2 parmi : se mettre au calme, contrôle de la respiration avec expiration lente, focaliser son attention sur autre chose, limiter l'hyperventilation)	3
Cite le traitement par benzodiazépine per os comme traitement ponctuel de crise éventuel	2
Cite les antidépresseurs/inhibiteurs sélectifs de la sérotonine comme traitement de fond éventuel	2
Conseille des règles hygiéno-diététiques à suivre, au moins 2 parmi les suivantes : arrêt des excitants (café, tabac), sommeil régulier, bon équilibre alimentaire, activité physique régulière, techniques de relaxation	3
Informe sur l'intérêt d'une thérapie cognitivo-comportementale	2
Informe sur le fonctionnement de la pathologie (crises d'abord spontanées puis provoquées par l'anticipation de futures crises)	1
NOTE	/40
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à écouter	0 à 2
Aptitude à questionner	0 à 2
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	0 à 2
Communication non verbale	0 à 2
Aptitude à proposer une prise en charge	0 à 2
NOTE TOTALE	/50